Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Santiago

Av. Batista Bonotto, 157 - Bairro: Centro - CEP: 97700000 - Fone: (55)3029-9981 - 55999337784 - Email: frsantiago2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000726-26.2023.8.21.0064/RS

AUTOR: DAVID ALMEIDA FRANCO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

DAVID ALMEIDA FRANCO, já qualificado, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPÊ/SAÚDE**, também qualificado, alegando em síntese ser portador de CÂNCER DE RIM METASTÁTICO (CID C 64). Disse que necessita utilizar o medicamento Nivolumabe (OPDIVO), todavia não dispõe de condição financeira para adquirir o fármaco e manter o tratamento. Destacou que a ausência de previsão em recomendações administrativas do IPE-Saúde não é motivo suficiente para negativa de autorização de tratamento indicado pelo médico. Referiu que o réu tem obrigação de fornecer o tratamento e acostou legislação e jurisprudência para comprovar seu direito. Requereu, em sede de tutela antecipada, o imediato fornecimento do medicamento de que necessita. Postulou ao final, dentre outros pedidos, pela procedência da demanda. Vindicou a AJG. Juntou documentos, evento 01.

Deferida a AJG e a tutela de urgência pleiteada, evento 04.

Citado o réu aportou contestação no evento 25 alegando ausência de cobertura do tratamento postulado. Teceu considerações acerca do sistema de saúde dos servidores públicos e sobre a manutenção de tal sistema. Falou sobre a cobertura do plano para medicamentos oncológicos; as alternativas para o tratamento de câncer dentro da cobertura do ipê-saúde e sobre a sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde-FAS. Falou sobre a necessidade da realização de exames periódicos. Postulou a improcedência da demanda. Acostou documentos, evento 25.

Embargos de declaração desacolhidos, evento 26.

Houve réplica, evento 34.

O Ministério Público devolveu os autos sem manifestação, evento 43.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATO.

PASSO A DECIDIR.

Cuida-se de ação em que a parte autora objetiva o fornecimento pelo réu do medicamento NIVOLUMABE.

Não há preliminares a serem analisadas e, no mérito procede o pedido da parte autora.

Consigno que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar as poucas condições financeiras da parte autora em despender da quantia necessária para a aquisição do fármaco que necessita.

Compulsando os autos, verifico que restaram comprovadas a existência da patologia, a necessidade e a urgência na administração do medicamento.

Os laudos médicos anexados evento 1, LAUDO8, evento 36, LAUDO2, comprovam a gravidade da doença que acomete o autor e a necessidade na administração do fármaco postulado. Constam nos referidos laudos que o autor foi submetido a outros tratamentos, que não surtiram o resultado esperado, pois os medicamentos causaram toxidade, sendo necessária a administração do fármaco postulado na inicial.

Verifico, ainda, que constam dos laudos que não há alternativa igualmente eficaz para tratar a enfermidade do autor, bem como que o autor já foi submetido a cirurgia e apresentou metástase cerebral:

O paciente DAVID ALMEIDA FRANCO apresenta Câncer de Rim metastático, doença sob o CID C 64, com metástase cerebral. Fez uso de pazopanibe, tendo apresentado toxicidade. Necessita de uso de Nivolumabe. O Nivolumabe está liberado em segunda linha para tratamento de câncer renal de células claras, tendo sido aprovado para uso tanto pelo FDA como pela ANVISA. Não poderá ser substituído por similares.

Em 2015 dois importantes estudos de fase III conseguiram demonstrar superioridade a **everolimo**. O estudo CheckMate-025 randomizou 821 pacientes com até duas linhas de tratamento com inibidores do VEGF (28% da população incluída) para receber **nivolumabe** *versus* **everolimo**. Observou-se aumento significativo na SG (sobrevida global) mediana (25 *versus* 19,6 meses; HR=0,73; IC de 95%: 0,57-0,93; p=0,018) e na RO (taxa de resposta) (25 *versus* 5%). Adicionalmente, **nivolumabe** foi mais bem tolerado, com menor incidência de eventos adversos grau ≥ 3 e melhores escores de qualidade de vida ao longo do tratamento. Avaliou-se também a expressão do PD-L1 como fator preditivo de resposta, mas não houve diferença do benefício de **nivolumabe** entre os pacientes com expressão de PD-L1 ≥ 1 ou < 1% [*N Engl J Med 373:1803, 2015*].

O paciente deverá fazer o uso da medicação nivolumabe, na dose de 480 mg endovenosa a cada 28 dias, o mais rápido possível, sob pena de progressão tumoral e aumento de chance de morte, sem o uso da medição citada. Essa medicação não deve ser substituída por similares ou genéricos.

EDILSON WALTER
MEDICINA INTERNA
ONCOLOGIA CLÍNICA
CREMERS 28118 - CPF 760.062.890-91

Edilson Walter
CREMERS 28118

QUESITOS COMPLEMENTARES AO LAUDO MÉDICO:

a) Não há caráter de urgência no tratamento. Urgência médica é classificada como doença ou situação clínica que pode causar risco de morte em até 72 horas. O paciente necessita de tratamento com brevidade para a sua enfermidade, sendo que o atraso pode vir a trazer danos e risco de vida. O nome da substância é Nivolumabe, sendo o nome comercial Optivo.
b) O paciente deve usar por tempo indeterminado. O medicamento só deve ser descontinuado se apresentar efeitos colaterais graves ou se o paciente apresentar progressão tumoral em vigência do uso do medicamento. O paciente está sendo avaliado a cada ciclo do tratamento.
c) Como já foi explicado no laudo, o medicamento aumenta sobrevida livre de doença e sobrevida global para o caso do paciente. Esse efeito é corroborado por estudos fase 3 e está liberado pela ANVISA para o uso (conforme laudo e dados do laudo ao IPE).
d) Não há via SUS (Sistema Único de Saúde) medicações disponíveis para o tratamento de câncer de rim metastático. Não existe valores de APAC (autorização de procedimento de alta complexicidade) que dão cobertura para qualquer medicamento com efetividade terapêutica para câncer renal metastático no SUS. O SUS não atualiza as APACs para câncer renal há mais de 15 anos. Lembrando que esse paciente tem convênio de saúde e que esse mediamento está no rol da ANS, sendo disponibilizado pela UNIMED, CASSI, BRADESCO e todos os outros convênios de saúde que eu tenho conhecimento.
e) Não tenho conhecimento de nenhum medicamento eficaz liberado pelo SUS para essa patologia, além do procedimento cirúrgico. O paciente em questão já fez os procedimentos cirúrgicos e apresentou metástase cerebral.
f) O atendimento se deu via IPE (convênio do IPE).
g) Não há lista do SUS para essa patologia pelo que sei. Não há APAC pelo SUS que dê cobertura para qualquer tratamento efetivo pelo SUS. O paciente pode vir a progredir a doença metastática caso não use o Nivolumabe.

Fico a disposição para qualquer outra explicação que seja necessária e sugiro, caso a Segunda Vara Cível de Santiago ache necessário, que o Serviço SUS de referência da área de ação da residência do paciente, seja questionado quanto as possibilidades do SUS de tratamento para o devida caso. A disposição!

Edilson Walter
CRM 28118
Oncologista Clínico

Ijuí, 01 de agosto de 2023

EDILSON WALTER
MEDICINA INTERNA
ONCOLOGIA CLÍNICA
CREMERS 28118 - CPF 760.062.890-91

Tenho que não pode ser afastada a credibilidade da prescrição efetuada pelo profissional que acompanha o tratamento do demandante, Dr. Edison Walter, CRM 28118, por possuir melhor condição de avaliar o seu estado de saúde e a prescrição recomendada.

Quanto ao fornecimento, ressalto que o pedido não se alicerça na responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, disposta no art. 196 da Constituição Federal, mas na responsabilidade do Plano de Saúde, assim necessário observar as normativas que regulamentam o plano.

Consigno que, em 06 de abril de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, revogando, portanto, a Lei Complementar nº 12.134/04.

Desta feita, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu após a entrada em vigor da LC 15.145/2018, esta é a legislação aplicável ao caso.

Tal legislação dispõe sobre o IPE-Saúde e refere que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, *in verbis*:

Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

O parágrafo primeiro do artigo acima refere que os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do IPERGS restam excluídos da cobertura do plano de saúde e o parágrafo segundo exige a aprovação do Órgão Gestor para inclusão de novos procedimentos, *in verbis*:

§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

Todavia, em que pese as disposições da nova lei, entendo que, neste caso, a ausência de previsão não deve servir de obstáculo ao fornecimento do medicamento postulado.

No caso em tela, o autor é segurado do plano de saúde e comprovou ser portador de Câncer de Rim metastático, doença sob CID C 64, bem como, acostou aos autos documento médico que evidencia necessitar do medicamento postulado.

Consigno que descabe a intervenção do plano de saúde na autonomia do médico, devendo ser respeitada a prescrição trazida pelo profissional que acompanha de forma direta a patologia do autor.

Cabe destacar que a Resolução nº 21/1979, que regulamenta a assistência Médico-Hospitalar do IPERGS, assim dispõe:

Artº 2º - O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.

§ Primeiro – O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.

§ Segundo – O Plano será fundamental baseado nos seguintes princípios:

a) co-participação financeira do usuário.

b) livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciadas.

Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades:

Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, ***Oncologia,*** *Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia. (Grifei)*

(…)

Artº 9º - A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:

1 – Emergências

2 – Consultas Médicas

3 – Serviços Complementares

4 – Tratamento Ambulatorial

5 – Tratamento Hospitalar

Desta feita, entendo que o plano de saúde deve fornecer o medicamento postulado, pois comprovada a enfermidade que acomete o autor, a cobertura do plano para tal enfermidade e a necessidade do uso do medicamento/tratamento.

É importante também lembrar que a limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao seu paciente é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI), conforme se segue:

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente."

Também deve ser observado o princípio da boa-fé contratual, pois se o plano oferece cobertura para a enfermidade do autor tal cobertura deve ser a mais ampla possível, sendo irrelevante se o Plano de saúde se institui na modalidade privada ou de autogestão.

Feitos estes esclarecimentos, verifica-se que a inovação legislativa não obstaculiza o direito da parte autora à saúde.

Da mesma forma, estando prevista a patologia que acomete a demandante no rol de cobertura do Plano, não há que considerar os argumentos com relação ao alto custo do procedimento ou eventuais prejuízos financeiros mencionados pelo réu, tratando-se de cumprimento das obrigações contratuais contraídas, pois a autora aderiu ao plano e cabe ao réu oferecer a cobertura contratada.

Ainda, o fato de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não exime o réu de custear o tratamento.

Desta feita é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

Neste sentido entendimento jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. *IPE*-SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ADENOCARCINOMA DE CÓLON, METASTÁTICO PARA PULMÃO E FÍGADO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. BEVACIZUMABE (AVASTIN). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. O segurado do *IPE*-SAÚDE tem direito ao recebimento de fármaco indispensável ao tratamento de sua grave moléstia, uma vez que a especialidade *oncologia* a que relacionada está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do *IPE*-SAÚDE, do *medicamento* indicado não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, credenciado pela Autarquia, que o teve como sendo o adequado e necessário para o tratamento, até porque insatisfatória anterior abordagem com outro fármaco constante nas Recomendações Técnicas em *Oncologia* da Autarquia. Fármaco objetivado na demanda que é contemplado nas Recomendações da autarquia, ainda que para neoplasia distinta da que acomete o autor. Em se tratando de ação em que visada a dispensação de tratamento, de vultoso valor, ainda que proposta em face de autarquia pública gestora de plano de saúde, pertinente a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência mediante critério equitativo, como previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, nos moldes do que se vem admitindo naquelas causas ajuizadas em face do Estado, latu senso, para compeli-lo ao cumprimento do seu dever constitucional de prestar os meios de que necessita o cidadão desvalido para a proteção de sua saúde. Em um e outro caso, o valor saúde, inestimável, prepondera em relação ao aspecto econômico. Honorários arbitrados mediante apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50044315120208210027, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 30-06-2021). Grifei.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPERGS. *IPÊ*-SAÚDE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. FORNECIMENTO DE *MEDICAMENTO*. RIBOCICLIBE (KISQUALI®). TRATAMENTO *ONCOLÓGICO*. NEGATIVA ADMINISTRATIVA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO *IPÊ*-SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA *MÉDICA* JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADOR PARTICULAR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. MINORAÇÃO. CABIMENTO. 1. Uma vez comprovada a cisão do IPERGS em *IPÊ*-SAÚDE e *IPÊ*-PREVIDÊNCIA, impõe-se a retificação do polo passivo da presente demanda. 2. Em que pesem as disposições da Lei Complementar nº 15.145/18, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo *Oncológico* não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento *médico* postulado. Inclusive, válido ressaltar que, de acordo com as Recomendações em *Oncologia* do próprio Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, atualizadas em dezembro de *2018* – elaboradas pelo Comitê Científico de *Oncologia* e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul – as orientações ali constantes não têm pretensão de ser completas ou definitivas, restando destacado, ainda, que "não tem como objetivo interferir na conduta *médica* ou autonomia profissional" e que "casos excepcionais e não previstos neste momento poderão ser encaminhados para discussão", sendo que estes *medicamentos* "serão revisados continuamente". 3. Assim, considerando que as Recomendações não apresentam caráter definitivo ou excludente – e, ao revés, preveem expressamente a possibilidade de exame de casos excepcionais, bem como a não intervenção na autonomia do *médico* assistente –, desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento *médico oncológico* cujos protocolos adotados não se pretendem definitivos e se encontram, em contínua revisão, mormente quando a perícia *médica* judicial é favorável à pretensão da demandante. 4. Ainda que assim não fosse, ao Plano de Saúde não cabe selecionar o tipo de tratamento que será coberto. Ou seja, assim como ocorre nos Planos de Saúde de natureza privada, se há previsão contratual de cobertura da patologia, não cabe ao Plano de Saúde ou ao Poder Judiciário selecionar o tipo de tratamento que terá ou não cobertura. Exegese do art. 422 do Código Civil, pois naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura (no caso, *oncologia*), entende-se que ela deve ser a mais ampla possível. Precedentes do STJ e deste TJRS. 5. Considerando o valor inestimável do direito à saúde, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por apreciação equitativa do julgador, por força do §8º do art. 85 do CPC/2015 e em observância aos vetores do §2º do mesmo artigo, notadamente porquanto o condenado é a Fazenda Pública. 6. Minoração do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, tendo em vista os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos e em conformidade com os critérios do §2º do art.85 do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084342450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-07-2020). Grifei

Ementa: TRATAMENTO DE SAÚDE. IPE-SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO. RESSARCIMENTO. COBERTURA. RESTRIÇÃO. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM TABELAS PRÓPRIAS. LC 15.145/2018. 1. O plano de saúde, inclusive no regime de autogestão, não pode excluir, da cobertura, procedimento, medicamento ou material para tratamento de doença prevista no contrato. Jurisprudência do STJ. 2. Afigura-se ilegal a recusa do IPE-SAÚDE em custear procedimentos, exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento à saúde do segurado ainda que não constem das suas tabelas. Precedentes deste Tribunal. Assim, está obrigado a ressarcir os valores despendidos referentes ao material cirúrgico ("cateter periférico angiojet"), utilizado em cirurgia de urgência, prescrito por médico conveniado. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70084881192, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 03-03-2021). Grifei.

Desse modo, entendo que o demandado deve arcar com as despesas do medicamento solicitado pela parte autora.

Por fim, nas ações de medicamentos deixo de fixar os honorários contra a Fazenda Pública constantes do art. 85 § 3º 4º e 5º do CPC, pois tal fixação iria onerar demasiadamente os entes públicos em decorrência de ações que são simples e repetitivas e que não exigem trabalho excessivo do (a) procurador (a).

Consigno, ainda, que a fixação dos honorários nos termos do art. 85 § 4º, inc. III do CPC acarretaria prejuízo a Fazenda Pública, pois o valor da causa nestes tipos de ações, na maioria das vezes, é arbitrada pelo valor dos fármacos, o que acarreta honorários significativos em caso de medicamentos/procedimentos de custo elevado.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DAVID ALMEIDA FRANCO para CONDENAR o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPÊ/SAÚDE a fornecer ao autor o medicamento postulado na inicial, qual seja: Nivolumabe (OPDIVO) na forma e prescrição postuladas.

Confirmo a decisão antecipatória da tutela, evento 04.

Deixo de condenar o réu em custas diante da isenção oferecida pela Lei nº 14.634/2014 e contida no Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ para ações desta natureza, ajuizadas a partir de 15/06/2015.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador do autor os quais fixo em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o valor deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC, na forma do artigo 3º da EC 113/2021[1].

Transitada em julgado, e nada mais sendo postulado, arquive-se com baixa na distribuição.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Partes intimadas.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA NICHEL SANTOS, Juíza de Direito**, em 24/6/2024, às 11:0:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10061783552v7** e o código CRC **7e3dc9b4**.

---

1. Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ↩